

УДК:616-006.6:615.849

Ж.К.Джарылкасинова

Жамбылский областной онкологический диспансер г.Тараз

Паллиативное лечение больных с метастатическим поражением костей

Аннотация. В данной статье описываются метастазы в костную ткань, как одно из частых поражений при раке предстательной и молочных желез, легкого, почки и щитовидной железы. Описывается клиническая картина и методы лечения при метастатических поражениях костей.

Ключевые слова: рак предстательной железы, рак молочной железы, метастазы в костной ткани.

Костная ткань является объектом метастазирования, как и все другие ткани. Наиболее часто в кости метастазирует рак предстательной и молочной желез, легкого, щитовидной железы, почки.

Злокачественные опухоли нередко сопровождаются поражением костей и нарушениями минерального обмена (в том числе кальциевого гомеостаза), болями, патологическими переломами и гиперкальциемией. Эти клинические симптомы преимущественно наблюдаются при наличии остеолитических метастазов, но могут быть также при генерализованном остеолитическом процессе, развивающемся вследствие эктомической продукции гормонов.

Независимо от того, имеет ли место местный или генерализованный остеолитический процесс, патогенез усиленной костной резорбции обусловлен нарушениями нормального механизма костеобразования. В основе его лежит активизация резорбтивных процессов в костной ткани вследствие влияния метастатических клеток.

Метастатическое поражение костей

Костная ткань является объектом метастазирования, как и все другие ткани. Наиболее часто в кости метастазирует рак предстательной и молочной желез, легкого, щитовидной железы, почки (таблица).

Таблица - Частота метастатического поражения костей, по данным аутопсий при опухолях различных локализаций

Локализация опухоли	Частота метастазов в кости(в%)
Молочная железа	47-85
Предстательная железа	54-85
Легкие	32-64
Щитовидная железа	28-60
Почка	33-60
Шейка матки	50
Мочевой пузырь	42
Печень	16
Яичники	9
Пищевод	5-7
Прямая кишка	8-13

Метастазами преимущественно поражаются позвоночник, проксимальная часть бедренной и плечевой костей, кости таза, ребра, грудина.

Костные метастазы могут быть остеолитическими,

остеобластическими и смешанными.

Клиника. Клиническая картина метастазов в кости при злокачественных опухолях включает в себя болевой синдром, деформации и патологические переломы, а также гиперкальциемию. Исключительно редко метастатическое поражение костей бывает бессимптомным.

Лечение. Лечение больных с метастазами в кости предполагает использование следующих методов:

- противоопухолевая терапия (химиотерапия, гормонотерапия);
- хирургическое лечение;
- обезболивающая лучевая терапия;
- системная радионуклидная терапия;
- кальцитонин;
- бисфосфонаты;
- анальгетики.

Противоопухолевая терапия (химиотерапия, гормонотерапия) является основным методом лечения больных раком молочной и предстательной желез, лимфомами, герминогенными опухолями и метастазами в кости. Однако это не исключает одновременного использования и других перечисленных выше методов, которые должны дополнять основное противоопухолевое лечение.

Лучевая терапия является стандартным высокоэффективным методом лечения болевого синдрома. В большинстве случаев анальгезирующий эффект удается достичь уже после нескольких фракций облучения. Этот метод по-прежнему следует использовать в практической деятельности.

Кальцитонин – это пептидный гормон, который секретируется С-клетками щитовидной железы и физиологическая роль которого состоит в регуляции обмена кальция и фосфора. Механизм действия заключается в ингибировании функциональной и пролиферативной активности остеокластов. Клинически доступен препарат кальцитонина, полученный из лосося – миокальцик. Относительная активность его у больных с костными метастазами ниже, чем у бисфосфонатов. Все это ограничивает широкое практическое его использование.

Биофосфонаты являются аналогами пирофосфата.

Препараты этой группы характеризуются продолжительной активностью, которая сохраняется длительное время даже после прекращения и обусловлена их депонированием в минеральной части костного матрикса.

В настоящее время для практического применения доступна большая группа бисфосфонатов. Они обладают разной антирезорбтивной активностью. Они обладают разной антирезорбтивной активностью *in vitro* и *in vivo* в эксперименте. (этидронат, клондронат, памидронат, алендронат, ибандронат, золендронат).

В последние годы лечебные возможности

бисфосфонатов активно изучаются во множестве клинических исследований, результаты которых иногда достаточно противоречивы. Поэтому практически врачами могут быть использованы недавно сформулированные рекомендации ASCO для больных раком молочной железы.

Наличие рентгенологических признаков метастазов в кости.

- Литические метастазы- показано применение бисфосфонатов наряду с химиотерапией или гормонотерапией.

- Наличие болевого синдрома при условии позитивного сканирования костей компьютерной томографии или ядерно-магнитного резонанса и отсутствия рентгенологических доказательств поражения скелета целесообразно проведение терапии бисфосфонатами.

- Позитивное сканирование костей, но отсутствие болевого синдрома и рентгенологических доказательств метастазов в кости- нецелесообразно лечение бисфосфонатами.

- Продолжительность лечения бисфосфонатами- рекомендуется продолжать лечение до значительного ухудшения общего состояния больной.

- Использование бисфосфонатов для лечения болевого синдрома, обусловленного метастазами в кости,- бисфосфонатами не могут полностью заменить существующие стандартные методы анальгезии (аналгетики, лучевая терапия), но могут применяться наряду с ними и противоопухолевой химиотерапией или гормонотерапией.

- Использование бисфосфонатов при отсутствии признаков метастатического поражения костей:

- при наличии экстраоссальных метастазов- не рекомендуется;

- с адъювантной целью – не рекомендуется, так как нет данных, подтверждающих снижение частоты метастазов в кости.

В связи с тем, что кость, пораженная метастазом является полноценной, существует постоянная вероятность ее перелома. Прежде всего, это касается позвонков. Снижению вероятности подобных переломов может способствовать ношение больными корсета с целью разгрузки отдельных отделов позвоночника. Корсет больные должны носить постоянно, снимая его только в горизонтальном положении. Это необходимо помнить и рекомендовать всем больным.

Таким образом, проблема метастатического поражения костей при солидных опухолях представляется высокоактуальной. Современные возможности

комплексного лечения больных с этой патологией позволяют обеспечить относительно удовлетворительное качество жизни больных.

Список литературы

1. Кондратьев В.Б.. *Метастазы в кости: осложненные формы, гиперкальциемия, синдром компрессии спинного мозга, медикаментозное лечение* // *Практ. онкол.* - 2000. - №2 – С. 41-45
2. Л.И.Корытова, Т.В.Хазова, Р.М.Жабина. *Лучевая терапия распространенного и метастатического рака молочной железы* // *Практическая онкол.* - 2000. - №2. - С. 46-49.
3. Coleman R.E., Rubens R.D.. *The clinical course of bone metastases from breast cancer* // *Brit. J. Cancer* - 1987. - Vol.55. - P.61-66.
4. Elomaa I., Blomqvist C. *Clodronate and other bisphosphonates as supportive therapy in osteolysis due to malignancy* // *Acta Oncol.* - 1995. - Vol.34 – P.629-636
5. Tubiana M. *Hulin. Incidence, prevalence and distribution of bone metastases* // *Bone*. - 1991. – Vol. 12. – P. 10

Тұжырым

Ж.К.Джарылкасинова

Жамбыл ауданының онкологиялық диспансері

Сүйектің метастазбен зақымдануы бар науқастың паллиативті емі

бұл мақалада аталық безінің, сүт безінің, қалқан безінің, өкпенің, бүйректің қатерлі ісіктерінің сүйекке шапқандығы жазылған.

Қатерлі ісіктердің сүйекке шапқандығының клиникалық сүйреттемесі және емдеу тәсілдері көрсетілген.

Түйінді сөздер: аталық безінің рагы, сүт безінің рагы, сүйектің метастазбен зақымдалуы.

SUMMARY

Z.S.Dzharylkasinova

Dzhambul Regional Oncology Center

Palliative treatment of patients with metastatic bone disease -

This article describes the metastasis to bony tissue, as one of the most common lesions when there is a cancer of prostate, breast, lung, kidney and thyroid. Clinical presentation and treatment methods are described for cases with metastatic bones disorder.

Keywords: prostate cancer, breast cancer, bone disease metastatic.